TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

HỘI THẢO

"Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng"

Trách nhiệm - Chất lượng - Phát triển - Hội nhập
Responsibility - Quality - Development - Integration

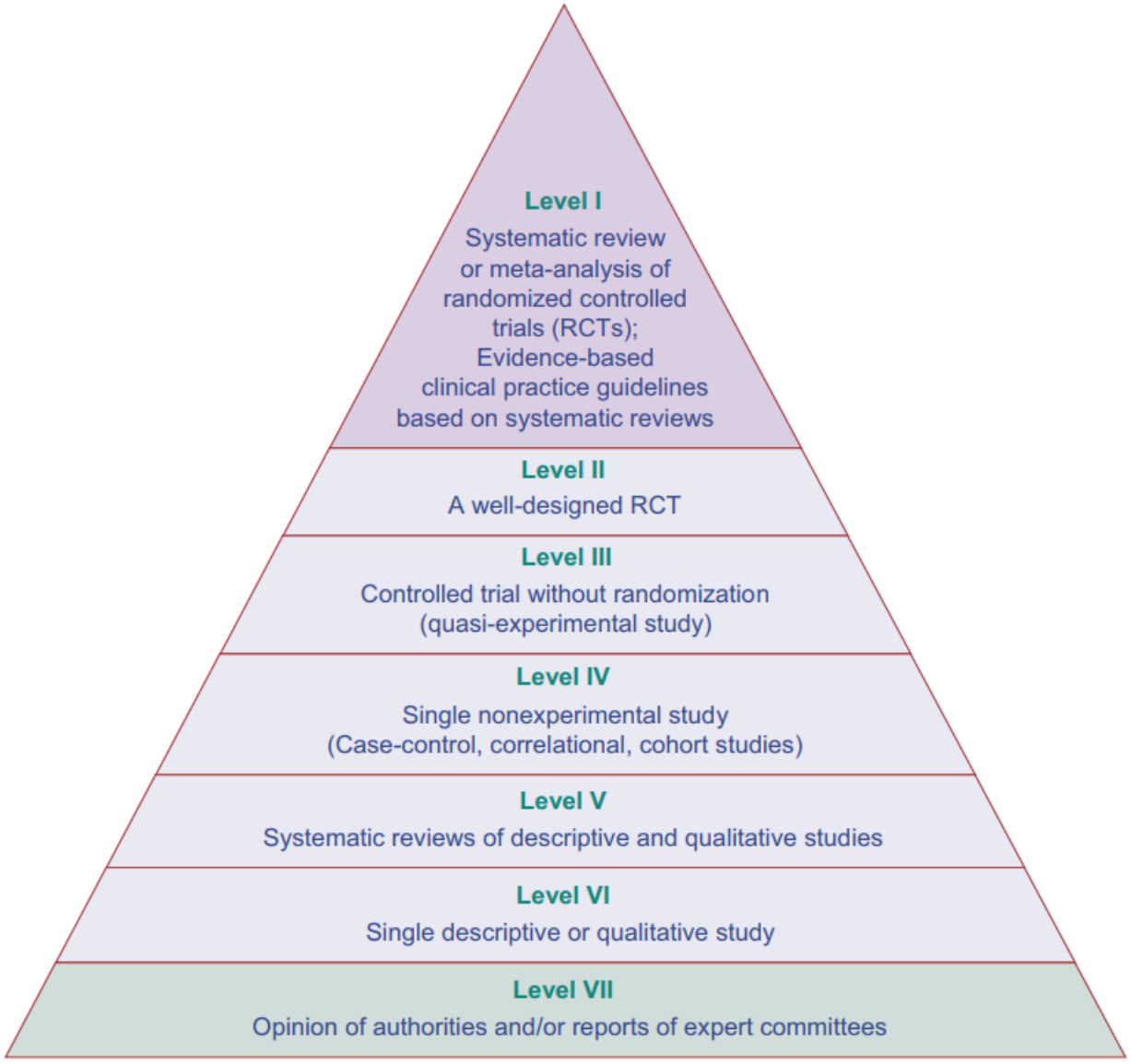
TUẦN 3
26/2/2022

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM BẰNG CHỨNG KHOA HỌC

PGS.TS.BS.PHẠM LÊ AN
CNĐD. MAI NGUYỄN THANH TRÚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Phân loại cấp độ bằng chứng



Geri LoBiondo-Wood

I HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
MEDICINE AND PHARMACY

Phân loại cấp độ bằng chứng

- 1A= Tổng quan hệ thống các nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs)
- 1B= Tổng quan hệ thống các nghiên cứu thử nghiệm không ngẫu nhiên
- 2A= Nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên có nhóm chứng đơn lẻ
- 2B= Nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên đơn lẻ
- 3= Tổng quan hệ thống nghiên cứu tương quan, nghiên cứu mô tả
- 4= Nghiên cứu tương quan, quan sát đơn lẻ
- 5= Tổng quan hệ thống nghiên cứu mô tả/định tính/sinh lý học
- 6= Nghiên cứu mô tả/định tính/sinh lý học
- 7= Ý kiến của chuyên gia, hội đồng chuyên môn

Phân loại cấp độ bằng chứng

- **Mức độ A:** Nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên có nhóm chứng, các nghiên cứu tổng quan hệ thống
- **Mức độ B:** Nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu bán thực nghiệm, nghiên cứu đoàn hệ, báo cáo ca/loạt ca, nghiên cứu quan sát mô tả
- **Mức độ C:** Ý kiến chuyên gia

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

➢ **GRADE:** Grading of Recommendations – Assessment – Development – Evaluations

- Phát triển và trình bày tóm tắt bằng chứng và cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để đưa ra các khuyến cáo thực hành lâm sàng
- Là công cụ được chấp nhận rộng rãi để đánh giá chất lượng bằng chứng
- Hơn 100 tổ chức trên thế giới sử dụng

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

- ✓ Agency for Healthcare Research and Quality (USA)
- ✓ Centers for Disease Control and Prevention (USA)
- ✓ German Cochrane Centre (Germany)
- ✓ McMaster University (Canada)
- ✓ Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (France)
- ✓ The Cancer Council (Australia)
- ✓ Center for Evidence Based Medicine (UK)
- ✓ BMJ Clinical Evidence (UK)
- ✓ University of London (UK)

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

Assessing Quality of the Evidence: GRADE

We assess the body of evidence available for each outcome using the **GRADE** (**G**rading of **R**ecommendations, **A**ssessment, **D**evelopment & **E**valuation) system

For each body of evidence we make assessments across 5 domains

Risk of Bias	Consistency	Directness	Precision	Reporting Bias
Any methodological limitations or flaws?	How much variation between studies (direction and size of estimates)?	How well does it match the PICO statement?	Enough participants or events? How wide is the confidence interval?	Any indications of publication bias?

These evaluations result in one of 4 quality ratings that reflects the degree of confidence that the available evidence correctly reflects the theoretical true effect of the intervention, service or practice

High	Moderate	Low	Very Low
true effect lies close to estimate; further research unlikely to change this	true effect lies close to estimate but possibility it is substantially different; further research may change estimate	true effect may be substantially different from estimate; further research very likely to have important impact on confidence and to change estimate	estimate of effect is very uncertain; further research very likely to have important impact on confidence and to change estimate

Each body of evidence begins with a high rating which is downgraded one level for every domain judged to have serious concerns (2 levels if concerns are very serious)

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

Levels and Grades of Evidence

Levels of Evidence and Grades of Recommendations

Grade of recommendation	Level of evidence	Interventions
A	1a	Systematic review of randomized controlled trials
	1b	Individual randomized controlled trial
B	2a	Systematic review of cohort studies
	2b	Individual cohort study
	3a	Systematic review of case-control studies
	3b	Individual case-control study
C	4	Case series
D	5	Expert opinion without explicit critical appraisal or based on physiology or bench research

REPROLINE, Johns Hopkins University www.reproline.jhu.edu

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

Symbol	Quality	Interpretation
⊕⊕⊕⊕	**High**	We are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect.
⊕⊕⊕O	**Moderate**	We are moderately confident in the effect estimate: the true effect is likely to be close to the estimate of the effect, but there is a possibility that it is substantially different.
⊕⊕OO	**Low**	Our confidence in the effect estimate is limited: the true effect may be substantially different from the estimate of the effect.
⊕OOO	**Very low**	We have very little confidence in the effect estimate: the true effect is likely to be substantially different from the estimate of effect.

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

*** Chất lượng bằng chứng phụ thuộc vào:**

- Thiết kế nghiên cứu (RCTs, bệnh chứng, …)
- Chất lượng nghiên cứu/giới hạn (làm mù, theo dõi, …)
- Tính nhất quán của kết quả nghiên cứu
- *Tính trực tiếp của bằng chứng:*
  - Đối tượng nghiên cứu (populations)
  - Phương thức can thiệp (interventions)
  - Mục tiêu (Outcomes)
  - So sánh (Comparison)

Phân loại bằng chứng theo GRADE System

- Chỉ xem xét những kết quả được đánh giá là nghiêm trọng
- Chất lượng bằng chứng được đánh giá là ngang nhau - > tổng hợp các bằng chứng để cùng trả lời cho câu hỏi lâm sàng
- Chất lượng bằng chứng khác nhau -> cân nhắc đến độ tin cậy

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

* Độ mạnh của bằng chứng (Strength of evidence)

- **Chất lượng (Quality):** Tổng hợp xếp hạng chất lượng cho các nghiên cứu riêng lẻ, được dự đoán về mức độ sai lệch đã được giảm thiểu
- **Số lượng (Quantity):** Tầm quan trọng của hiệu ứng, số lượng nghiên cứu và quy mô hoặc cỡ mẫu
- **Tính nhất quán (Consistency):** Mức độ nhất quán về các thiết kế nghiên cứu, mức độ liên quan, lợi ích và tác hại

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

*** Phân tích bằng chứng:**

- Nguồn gốc trích dẫn tài liệu (Citations)
- Câu hỏi nghiên cứu/Vấn đề nghiên cứu (Research Questions/Hypotheisis)
- Biến số độc lập và công cụ đánh giá (Independent Variables/Measures)
- Biến số phụ thuộc và công cụ đánh giá (Dependent Variables/Measures)
- Cỡ mẫu nghiên cứu (Sample Size Population)
- Kết quả nghiên cứu (Results)
- Độ mạnh bằng chứng (Strengths)
- Điểm mạnh/điểm yếu (Strength/Weakness)

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

*** Phân tích bằng chứng**

-> Phương pháp thực hiện:

✓ Hỗ trợ từ câu lạc bộ tạp chí/câu lạc bộ NCKH để thảo luận phân tích

✓ Có sự nhận xét/phê bình của nhóm chuyên gia

✓ Thu hút sự tham gia của nhiều chuyên ngành, cấp đào tạo có cùng mối quan tâm và quan điểm về vấn đề

Phân loại bằng chứng theo GRADE System

*** Tiêu chí đánh giá:**

- Sự phù hợp của bằng chứng đối với lĩnh vực thực hành tương ứng
- Tính nhất quán của các chỉ số trong nghiên cứu
- Đặc điểm của bằng chứng tương đồng với vấn đề lâm sàng
- Tính nhất quán giữa các bằng chứng với nhau
- Mức độ khả thi trong thực tế
- Tỷ lệ rủi ro/lợi ích trên bệnh nhân

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

- Nội dung bằng chứng cung cấp có tương ứng với vấn đề lâm sàng không?
- Bằng chứng có trình bày rõ ràng vấn đề nghiên cứu? Nếu thử nghiệm giả thuyết thì có trình bày giả thuyết một cách rõ ràng không?
- Bằng chứng có đưa đầy đủ thông tin về các nghiên cứu liên quan hoặc nghiên cứu trước đó không?
- Thiết kế nghiên cứu có được mô tả rõ ràng không?
- Đối tượng nghiên cứu có định nghĩa cụ thể không? Tiêu chuẩn chọn và loại?
- Nếu là nghiên cứu thử nghiệm, quá trình chọn mẫu có được miêu tả cụ thể không?
- Các biến số có được định nghĩa cụ thể không?

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

- Mục tiêu nghiên cứu có được trình bày từ đầu đến cuối không?
- Thiết kế nghiên cứu có phù hợp với vấn đề đặt ra không?
- Cỡ mẫu có đủ lớn để mang tính khái quát cho quần thể không?
- Kết quả nghiên cứu có được trình bày cụ thể không?
- Kết quả nghiên cứu trình bày có bám sát mục tiêu nghiên cứu không?
- Trích dẫn TLTK như thế nào, bao nhiêu TLTK?
- Thời gian của các TLTK?

GRADE cho người mới bắt đầu

Đánh giá chứng cứ

Hạn chế của nghiên cứu
Tính chính xác
Tính đồng nhất
Tính trực tiếp
Sai lệch công bố
Mức độ hiệu quả
“Hiệu quả theo liều”
Sự hợp lý

Sơ lược chứng cứ

Chứng cứ đến khuyến nghị

Ưu tiên?
Mức độ chắc chắn về giá trị của kết cục?
Mức độ chắc chắn tổng thể?
Hiệu quả mong muốn lớn?
Hiệu quả không mong muốn nhỏ?
Hiệu quả mong muốn so với không mong muốn?
Chi phí tăng lên so với lợi ích ròng?
Bất bình đẳng y tế?
Tính chấp nhận?

EtR framework

3 bước đánh giá độ mạnh của bằng chứng

1. **Đánh giá 4 lĩnh vực:** rủi rõ thiên lệch, tính nhất quán, tính trực tiếp, tính chính xác
2. **Có thể đánh giá bổ sung:** dose-response association, plausible confounders, strength of association, publication bias
3. Tính tổng điểm từ 4 lĩnh vực bắt buộc, có thể tính thêm ở các nội dung bổ sung

Rủi ro thiên lệch

- Mối quan tâm đến thiết kế nghiên cứu và tiến hành nghiên cứu
- Đánh giá chất lượng tổng hợp của các nghiên cứu trong mỗi thiết kế nghiên cứu chính và tích hợp các đánh giá đó vào một rủi ro tổng thể về điểm thiên vị
- **Điểm:**

+ Cao: giảm cường độ của loại bằng chứng
+ Trung bình
+ Thấp: nâng cao sức mạnh của loại bằng chứng

Tính đồng nhất

- Tiêu chuẩn tính đồng nhất:

+ Có cùng hướng tác động

+ Phạm vi kích thước hiệu ứng hẹp

- Tiêu chuẩn tính không đồng nhất:

+ Không rõ ràng khoảng tin cậy

+ Có sự không đồng nhất về mặt thống kê hoặc trên lâm sàng không giải thích được

- Điểm:

+ Nhất quán

+ Không nhất quán

+ Không áp dụng

Tính trực tiếp

- Phản ánh mối liên hệ trực tiếp, duy nhất giữa pp can thiệp của sự quan tâm và mục tiêu chăm sóc đang được xem xét, dựa trên nhiều liên kết trong một chuỗi nhân quả
- Nếu có nhiều liên kết, sức mạnh của bằng chứng chỉ có thể mạnh bằng liên kết yếu nhất
- Sử dụng khung phân tích là quan trọng

Tính trực tiếp

- **Điểm số:**

+ Trực tiếp: bằng chứng dựa trên mối liên hệ duy nhất giữa can thiệp và kết quả điều trị/chăm sóc

+ Gián tiếp: bằng chứng dựa trên kết quả thay thế

Tính chính xác

- **Định nghĩa:** là mức độ chắc chắn để ước tính ảnh hưởng đối với một kết quả cụ thể
- **Là một khái niệm tổng hợp về:**

+ *Đặt câu hỏi:* những người ra quyết định có thể kết luận gì về việc liệu một phương pháp điều trị, đang nói trên lâm sàng, thấp hơn, cao hơn, hoặc tương đương với một phương pháp điều trị khác?

+ *Cân nhắc về*: ý nghĩa thống kê đối với các ước tính ảnh hưởng, khoảng tin cậy đối với các ước tính ảnh hưởng đó

Tính chính xác

- Là các tỷ lệ riêng biệt cho từng kết quả hoặc so sánh quan trọng, bao gồm bất kỳ ước tính tóm tắt nào về quy mô ảnh hưởng

- **Điểm số:**

+ Chính xác: ước tính cho phép đưa ra kết luận hữu ích về mặt lâm sàng

+ Không chính xác: khoảng tin cậy quá rộng nên có thể bao gồm các kết luận khác biệt về mặt lâm sàng (thậm chí mâu thuẫn)

Thành phần đánh giá bổ sung

- **Bốn lĩnh vực "tùy ý":** hiệu quả theo liều, yếu tố gây nhiễu hợp lý, sức mạnh liên kết, sai lệch công bố
- **Sử dụng khi :**

+ Có thể áp dụng

+ Hữu ích trong việc đưa ra kết luận về điểm tổng thể cho sức mạnh của bằng chứng

Hiệu quả theo liều

- Mô hình của một hiệu ứng lớn hơn với sự tiếp xúc nhiều hơn (liều lượng, thời gian, sự tuân thủ) trong hoặc trong các nghiên cứu
- Xếp hạng nếu các nghiên cứu đưa ra mức độ phơi nhiễm
- **Điểm:**

+ Có xuất hiện: quan sát được mô hình phản ứng với liều lượng

+ Không xuất hiện: không quan sát thấy mô hình đáp ứng với liều lượng (không có mối quan hệ giữa liều lượng và phản ứng)

+ Không ứng dụng

Yếu tố gây nhiễu

- Trong một nghiên cứu quan sát. Đôi khi các yếu tố gây nhiễu hợp lý hoạt động theo hướng ngược lại với tác động quan sát được. Xem xét liệu có tồn tại sự nhiễu hợp lý có thể làm giảm tác động quan sát được hay không.
- ***Điểm:***

+ Có: có thể có các yếu tố gây nhiễu làm giảm hiệu ứng quan sát được

+ Không: các yếu tố gây nhiễu có thể làm giảm hiệu ứng quan sát được sẽ không xuất hiện

Sức mạnh liên kết

- **Tầm quan trọng của hiệu ứng:**

+ Được định nghĩa là khả năng ảnh hưởng được quan sát đủ lớn để nó không thể xảy ra chỉ do sai lệch từ các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn

+ Cân nhắc khi kích thước hiệu ứng đặc biệt lớn

- **Điểm:**

+ Mạnh: kích thước hiệu ứng lớn khó có thể xảy ra trong trường hợp không có tác dụng thực sự của can thiệp

+ Yếu: kích thước hiệu ứng đủ nhỏ mà nó có thể chỉ xảy ra do sai lệch từ các yếu tố gây nhiễu

Sai lệch công bố

- Các nghiên cứu có thể đã được xuất bản một cách chọn lọc
- Tác động ước tính của một can thiệp dựa trên các nghiên cứu đã được công bố không phản ánh hiệu quả thực sự.
- Sự sai lệch công bố có thể làm suy yếu tính chắc chắn tổng thể của khối bằng chứng

Quy trình đánh giá các lĩnh vực

- Sử dụng hai hoặc nhiều người đánh giá có chuyên môn phù hợp về phương pháp và lâm sàng.

- Đánh giá riêng:

+ Thành phần bắt buộc (hoặc thành phần tùy chọn, nếu có liên quan)

+ Mỗi kết quả chính, bao gồm cả lợi ích và tác hại

+ Giải quyết những khác biệt bằng sự đồng thuận hoặc hòa giải bởi một chuyên gia bổ sung; điểm số đồng thuận sẽ xuất hiện trong bảng.

+ Ghi lại và duy trì hồ sơ về các đánh giá riêng lẻ của từng người đánh giá về các miền làm tài liệu cơ bản

Phân loại bằng chứng theo GRADE System

- **Thang điểm phân loại:**

- 7 – 9: Bằng chứng quan trọng đối với đưa ra quyết định chăm sóc BN
- 4 – 9: Bằng chứng thích hợp nhưng không quan trọng
- 1 – 3: Bằng chứng không thích hợp đối với vấn đề lâm sàng

- **Vấn đề cân nhắc lựa chọn:** thời gian điều trị, tỷ lệ biến chứng, tác dụng phụ nghiệm trọng, ….

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

Yếu tố giảm chất lượng bằng chứng	Yếu tố tăng chất lượng bằng chứng
Hạn chế của nghiên cứu	Độ lớn của hiệu ứng
Tính mẫu thuẫn giữa các kết quả nghiên cứu	Biến số gây nhiễu hợp lý
Tính ảnh hưởng gián tiếp của bằng chứng/định hướng (directness)	Mối quan hệ nguyên nhân giả định giữa các nghiên cứu (Dose-Response Gradient)
Kết quả nghiên cứu rời rạc	
Sai lệch khi công bố/xuất bản	

Chất lượng bằng chứng	Thiết kế nghiên cứu	Giảm (nếu)	Tăng (nếu)
Cao	Thử nghiệm ngẫu nhiên	*** Chất lượng NC** - (-1): Hạn chế phạm vi áp dụng - (-2): Hạn chế rất nghiệm trọng *** (-1): Không nhất quán** ***Tính định hướng trực tiếp thấp (directness)** * (-1): Số liệu rời rạc * (-1): Sai lệch cao	+1: Không yếu tố gây nhiễu/nhất quán/định hướng trực tiếp cao + 2: Không yếu tố ảnh hưởng đến tính giá trị/định hướng + 1: Có bằng chứng đã được áp dụng ở những vấn đề tương tự và mang lại kết quả + 2: Tất cả các yếu tố gây nhiễu được kiểm soát ở mức cao nhất
Trung bình			
Thấp	Nghiên cứu quan sát		
Rất thấp	Các loại nghiên cứu khác		

Ví dụ

❖ **Vấn đề lâm sàng:** "Khoảng cách tiếp xúc >1m hay dưới 1m trong đại dịch COVID-19 "

- Đối tượng (Population): toàn bộ người dân
- Can thiệp (Interventions): áp dụng quy định giữ khoảng cách khi tiếp xúc
- So sánh (Comparison): Mức độ lây nhiễm giữa khoảng cách > 1m và <1m
- Mục tiêu (Outcomes): Giảm tỷ lệ lây nhiễm

-> Các bước thực hiện: xác định COVID-19 là gì?, đường lây?, …

Ví dụ

Open in new window

Author(s): Holger Schünemann, Derek Chu, Elie Akl
Question: A physical distance of more than one meter compared to one meter or less for people possibly exposed to patients infected or suspected to be infected with COVID-19
Setting: Any
Bibliography: Chu et al. prepared for publication

Certainty assessment							№ of patients		Effect		Certainty	Importance
№ of studies	Study design	Risk of bias	Inconsistency	Indirectness	Imprecision	Other considerations	a physical distance of more than one meter	one meter or less	Relative (95% CI)	Absolute (95% CI)		
Infection with COVID-19 (follow up: range 10 days to more days; assessed with: COVID-19, SARS, MERS infection)												
9	observational studies	not serious [a]	not serious [b]	not serious [c,d]	not serious	strong association [e,f]	97/5065 (1.9%) [g]	347/2717 (12.8%)	**OR 0.18** (0.09 to 0.38)	**102 fewer per 1,000** (from 115 fewer to 75 fewer)	⨁⨁⨁◯ MODERATE	CRITICAL
								5.0%		**41 fewer per 1,000** (from 45 fewer to 30 fewer)		
								50.0%		**347 fewer per 1,000** (from 417 fewer to 225 fewer)		

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. All studies were non-randomized and evaluated using the Newcastle-Ottawa Scale. Some studies had higher risk of bias than others but there was no important difference in the sensitivity analyses excluding studies at higher risk of bias. We did not further rate down for risk of bias.
b. Although there was a high I2 value and lack of overlapping confidence intervals, all point estimates of the studies exceeded the thresholds for large effects and we did not rate down for inconsistency.
c. We did not rate down for indirectness for the association between distance and infection because the SARS and COVID-19 virus belong to the same family and there is no evidence showing differences in terms of how the distance relates to their transmission
d. Some studies included the use of masks, but subgroup analysis did not reveal important differences. Some studies also used bundled interventions and the effect of distances could not be evaluated in isolation but the studies shown here include only those that provide adjusted estimates. We did not rate down for intervention indirectness.
e. The effect is large considering the thresholds set by GRADE assuming that the odds ration translate into similar magnitudes of relative risk estimates. This also mitigated concerns about risk of bias.
f. The data suggest a dose-response gradient with associations increasing from smaller distances to 2 meters and beyond. This was also suggested by a meta-regression. We did not rate up for this domain alone but in combination with the large effects.

Ví dụ

A physical distance of more than one meter compared to one meter or less for people possibly exposed to patients infected or suspected to be infected with COVID-19

Patient or population: people possibly exposed to patients infected or suspected to be infected with COVID-19
Setting: Any
Intervention: a physical distance of more than one meter
Comparison: one meter or less

Outcomes	Anticipated absolute effects* (95% CI)		Relative effect (95% CI)	№ of participants (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)	Comments
	Risk with one meter or less	Risk with a physical distance of more than one meter				
Infection with COVID-19 (Virus transmission) assessed with: COVID-19, SARS, MERS infection follow up: range 10 days to more days	**Study population**		**OR 0.18** (0.09 to 0.38)	7782 (9 observational studies)	⨁⨁⨁◯ MODERATE a,b,c,d,e,f	A physical distance of more than one meter likely results in a large reduction in infection with COVID-19. For each meter in distancing up to two meter, the relative effect may increase 1.57-times.
	128 per 1,000	**26 per 1,000** (13 to 53) g				
	Low					
	50 per 1,000	**9 per 1,000** (5 to 20)				
	High					
	500 per 1,000	**153 per 1,000** (83 to 275)				

*__The risk in the intervention group__ (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the **relative effect** of the intervention (and its 95% CI).

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

GRADE Working Group grades of evidence
High certainty: We are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect
Moderate certainty: We are moderately confident in the effect estimate: The true effect is likely to be close to the estimate of the effect, but there is a possibility that it is substantially different
Low certainty: Our confidence in the effect estimate is limited: The true effect may be substantially different from the estimate of the effect
Very low certainty: We have very little confidence in the effect estimate: The true effect is likely to be substantially different from the estimate of effect

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

GRADE

https://www.gradeworkinggroup.org/

Getting started

Browse our publications or learn hands-on. We'll get you started in no time.

Read

Clinicians and policy-making users and anyone new to GRADE may want to consider first reading the multi-part BMJ from 2008.

View

Have Dr. Gordon Guyatt explain GRADE or watch introductory lectures by Dr. Holger Schünemann.

Do

GRADEpro (now also called GRADEpro GDT app) - can be found on the GRADEpro website. GRADEpro and GRADEpro Guideline Development Tool are easy to use all-in-one web solution for summarizing and

GRADE events

Calendar

U.S. GRADE Network Systematic Review workshop
When: Tuesday February 1, 2022
Where: A virtual learning experience
Two day comprehensive Systematic Review course now open for registration

U.S. GRADE guideline workshop
When: Wednesday June 29, 2022
Where: Chicago, IL, USA
The 16th Guideline Development Workshop using GRADE. Wednesday through Friday, with pre-workshops on Tuesday (Nuts & Bolts of running a guideline program; systematic review refresher). Info at GRADEconf.org

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng

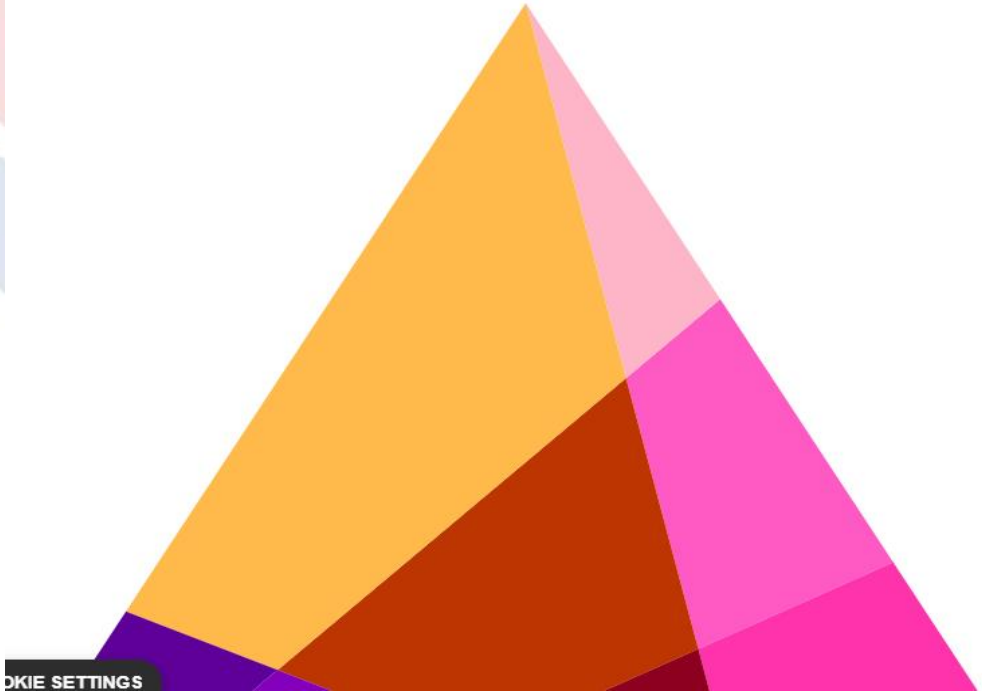
GRADEpro GDT

product extensions EtD's and Guidelines resources pricing contact log in

Happy World Evidence-Based Healthcare Day, everyone!

Standard plan for everyone - for free!

read more



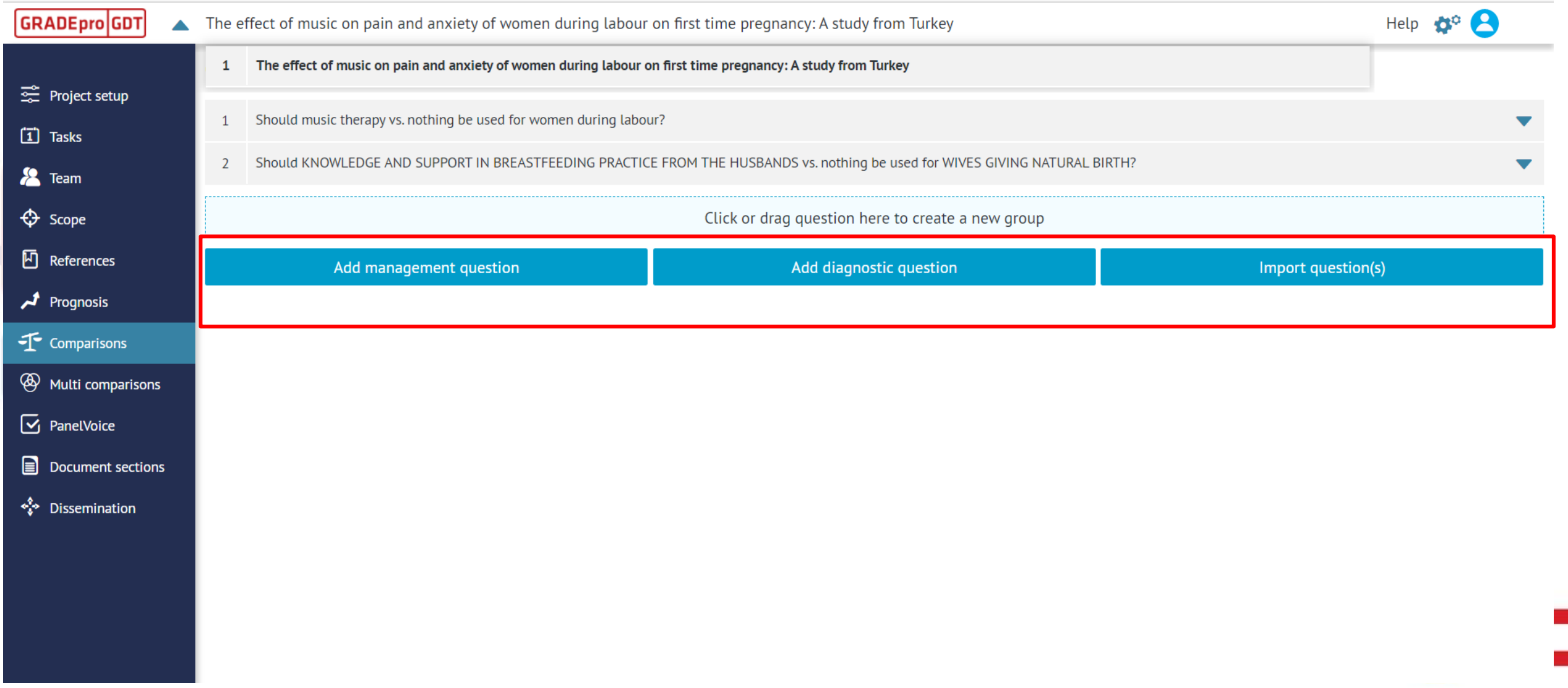
GRADE your evidence and improve your guideline development in health care

log in / sign up

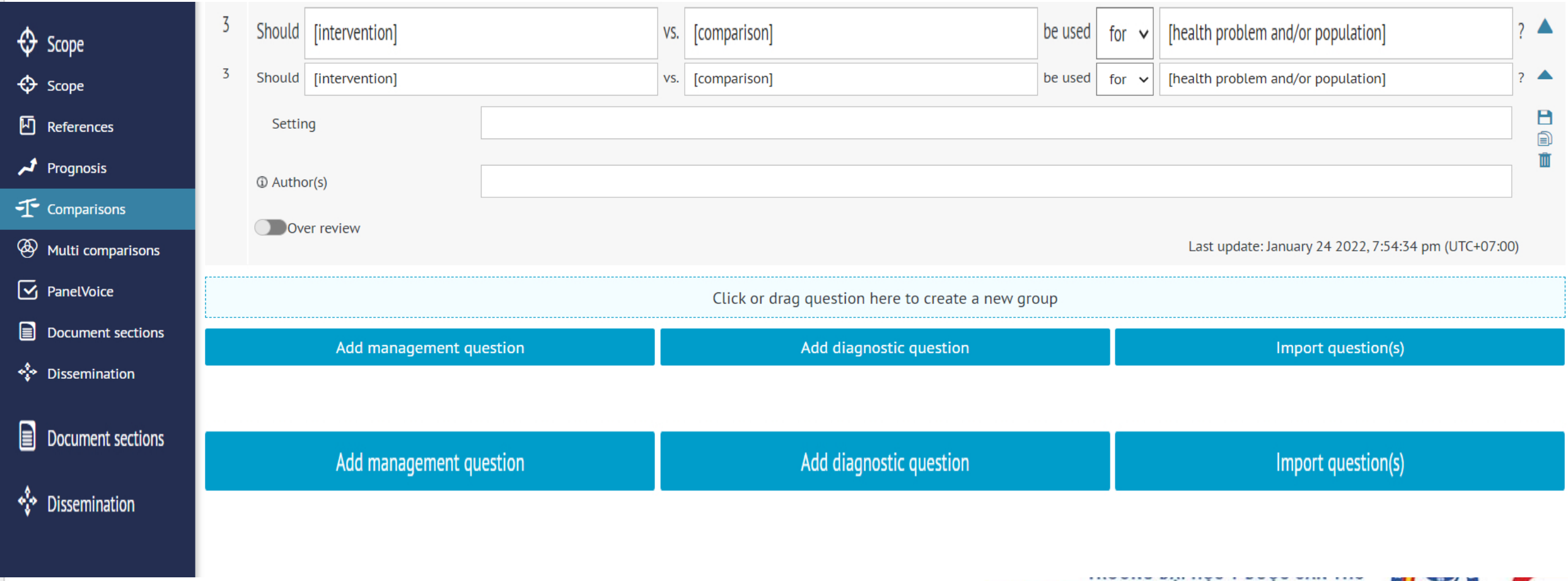
Creating guidelines with GRADEpro GDT is easy! Today with over 80.000 users GRADEpro has become a reference point for on how to enable and aid collaboration and

OKIE SETTINGS

GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng



GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng



GRADE và đánh giá chất lượng bằng chứng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Phương pháp tìm kiếm bằng chứng

- Bước 1: Xác định vấn đề cần thực hiện
- Bước 2: Xác định “keywords” liên quan đến vấn đề cần giải quyết
- Bước 3: Xác định các bằng chứng phù hợp với vấn đề
- Bước 4: Đánh giá bằng chứng theo hướng dẫn GRADE
- Bước 5: Chọn bằng chứng giải quyết vấn đề

Phương pháp tìm kiếm bằng chứng





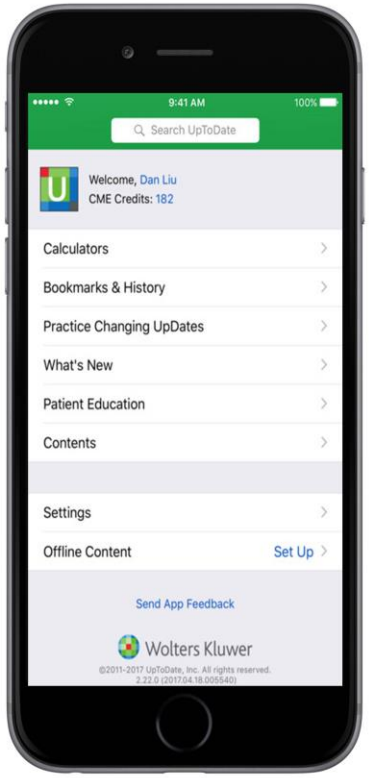


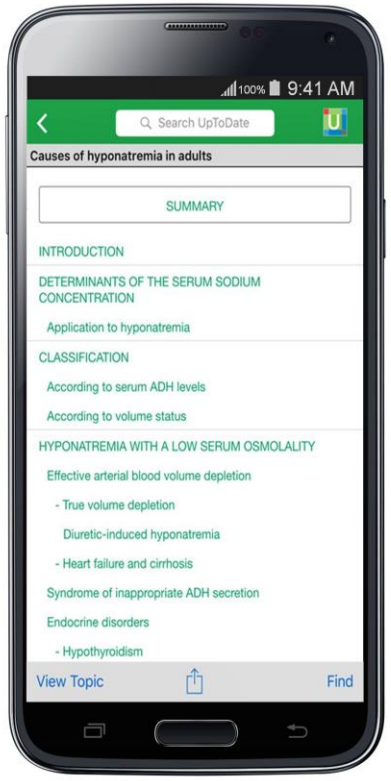


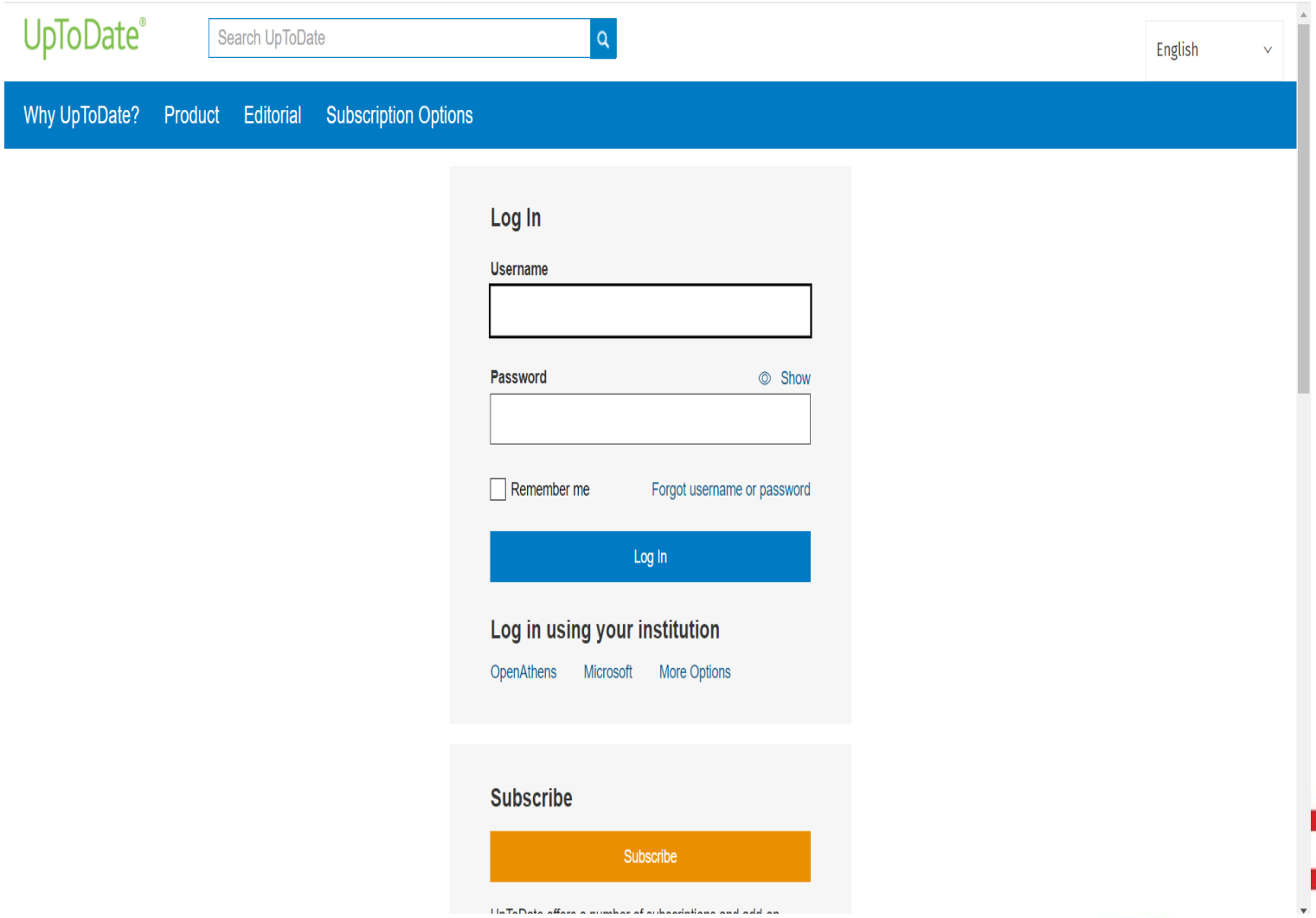
Phương pháp tìm kiếm bằng chứng

- **Uptodate là nguồn hỗ trợ ra quyết định thực hành lâm sàng**
- Hơn 36 500 tổ chức y tế trên thế giới sử dụng
- Hơn 6700 tác giả, biên tập viên và nhà phê bình nổi tiếng trên thế giới
- Hơn 1,3 triệu bác sĩ lâm sàng tại 187 quốc gia sử dụng
- > 90% trung tâm y tế chất lượng cao tại Mỹ đang sử dụng

Phương pháp tìm kiếm bằng chứng







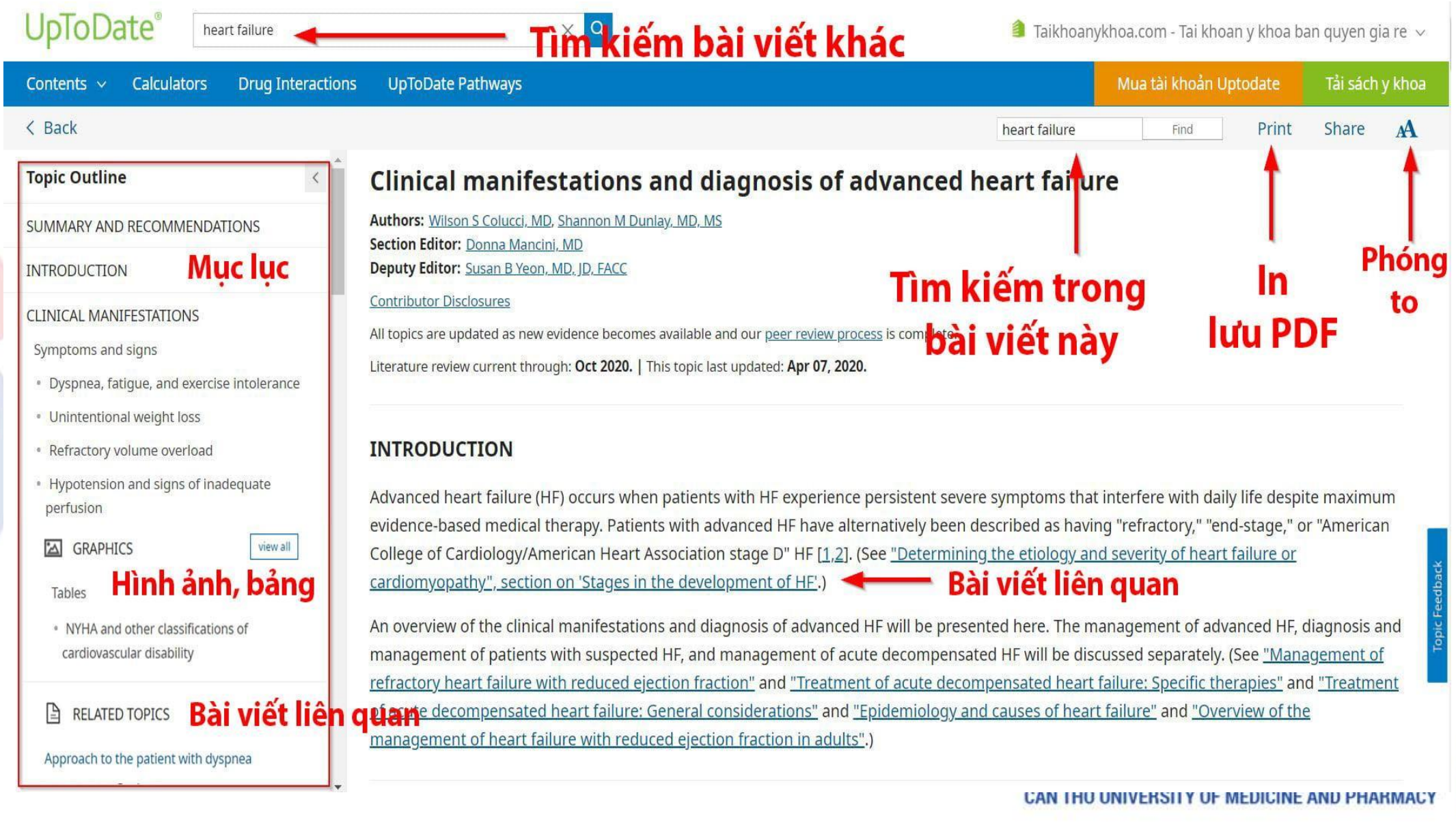
Phương pháp tìm kiếm bằng chứng

- Approach to + từ khoá: Tiếp cận bệnh nhân bị …
- Treatment of + từ khoá: Điều trị bệnh nhân bị …
- Clinical manifestations of + từ khoá: Biểu hiện lâm sàng …
- Cause + từ khoá : Nguyên nhân …
- Diagnosis + từ khoá: Chẩn đoán …
- Differential diagnosis + từ khoá: Chẩn đoán phân biệt …
- Evaluation + từ khoá: Đánh giá …
- Management + từ khoá: Quản lý …
- Epidemiology + từ khoá: Dịch tễ …
- Prognosis of + từ khoá: Tiên lượng

Phương pháp tìm kiếm bằng chứng

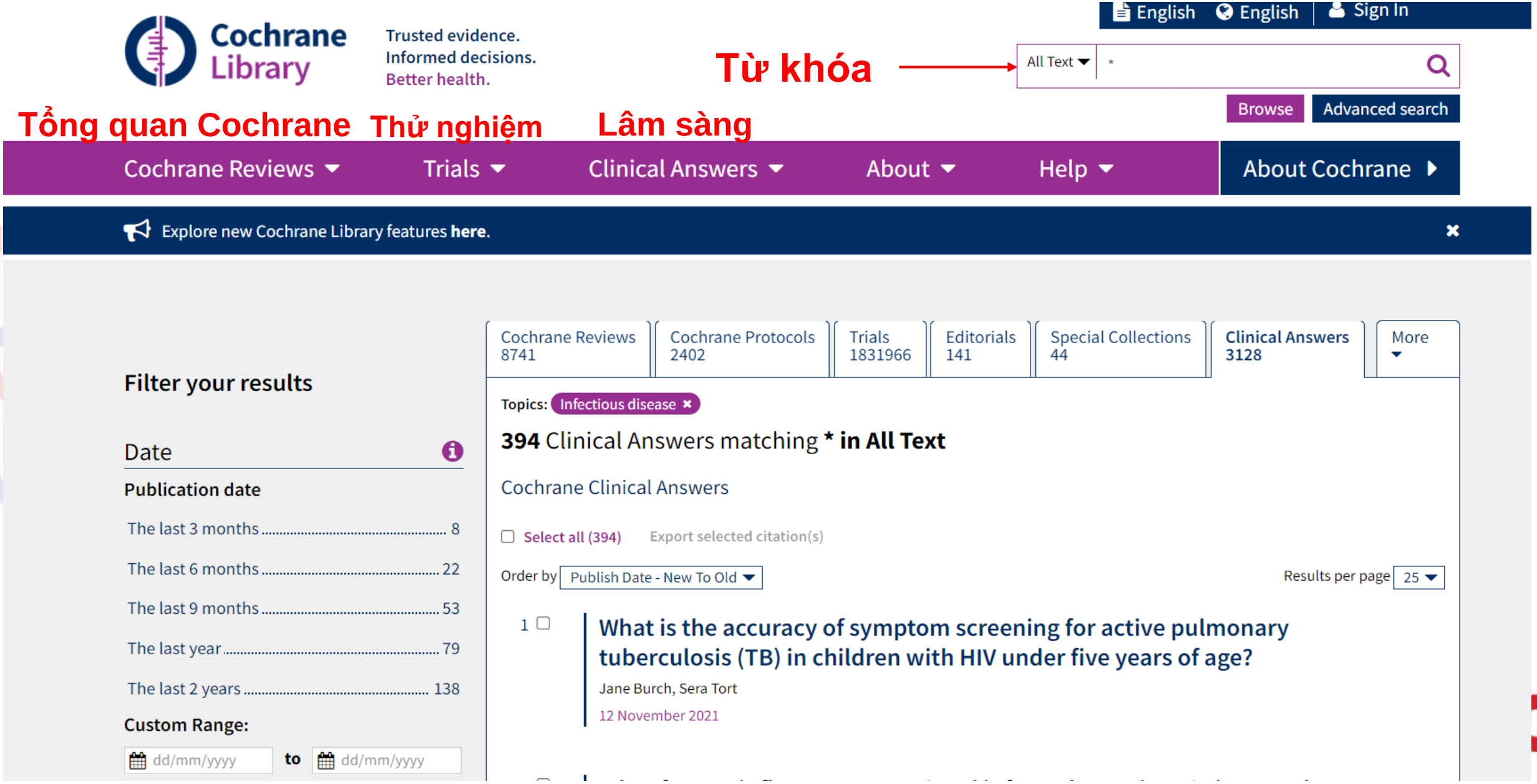
Tìm kiếm bài viết




UpToDate
heart failure
Tìm kiếm bài viết khác
Taikhoanykhoa.com - Tai khoan y khoa ban quyen gia re
Contents
Calculators
Drug Interactions
UpToDate Pathways
Mua tài khoản Uptodate
Tải sách y khoa
Back
heart failure
Find
Print
Share
Topic Outline
SUMMARY AND RECOMMENDATIONS
INTRODUCTION
Mục lục
CLINICAL MANIFESTATIONS
Symptoms and signs
Dyspnea, fatigue, and exercise intolerance
Unintentional weight loss
Refractory volume overload
Hypotension and signs of inadequate perfusion
GRAPHICS
view all
Tables
Hình ảnh, bảng
NYHA and other classifications of cardiovascular disability
RELATED TOPICS
Bài viết liên quan
Approach to the patient with dyspnea
Clinical manifestations and diagnosis of advanced heart failure
Authors: Wilson S Colucci, MD, Shannon M Dunlay, MD, MS
Section Editor: Donna Mancini, MD
Deputy Editor: Susan B Yeon, MD, JD, FACC
Contributor Disclosures
All topics are updated as new evidence becomes available and our peer review process is complete.
Literature review current through: Oct 2020. | This topic last updated: Apr 07, 2020.
Tìm kiếm trong bài viết này
In lưu PDF
Phóng to
INTRODUCTION
Advanced heart failure (HF) occurs when patients with HF experience persistent severe symptoms that interfere with daily life despite maximum evidence-based medical therapy. Patients with advanced HF have alternatively been described as having "refractory," "end-stage," or "American College of Cardiology/American Heart Association stage D" HF [1,2]. (See "Determining the etiology and severity of heart failure or cardiomyopathy", section on 'Stages in the development of HF'.)
Bài viết liên quan
An overview of the clinical manifestations and diagnosis of advanced HF will be presented here. The management of advanced HF, diagnosis and management of patients with suspected HF, and management of acute decompensated HF will be discussed separately. (See "Management of refractory heart failure with reduced ejection fraction" and "Treatment of acute decompensated heart failure: Specific therapies" and "Treatment of acute decompensated heart failure: General considerations" and "Epidemiology and causes of heart failure" and "Overview of the management of heart failure with reduced ejection fraction in adults".)
Topic Feedback
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Phương pháp tìm kiếm bằng chứng

- Thư viện Cochrane là cơ sở tập hợp dữ liệu các bài tổng quan hệ thống (systematic reviews) và phân tích gộp (meta-analysis)
- Là hệ thống dữ liệu quan trọng trong việc áp dụng EBP trong thực hành lâm sàng cho bác sĩ và điều dưỡng
- Được sử dụng phổ biến tại các Mĩ, Canada, Châu Âu, Châu Á
- Cung cấp các dữ liệu về tổng quan hệ thống, phân tích gộp, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu vấn đề lâm sàng


Cochrane Library
Trusted evidence.
Informed decisions.
Better health.
English
English
Sign In
Từ khóa
All Text
*
Browse
Advanced search
Tổng quan Cochrane
Thử nghiệm
Lâm sàng
Cochrane Reviews
Trials
Clinical Answers
About
Help
About Cochrane
Explore new Cochrane Library features here.
Cochrane Reviews 8741
Cochrane Protocols 2402
Trials 1831966
Editorials 141
Special Collections 44
Clinical Answers 3128
More
Filter your results
Date
Publication date
The last 3 months 8
The last 6 months 22
The last 9 months 53
The last year 79
The last 2 years 138
Custom Range:
dd/mm/yyyy
to
dd/mm/yyyy
Topics: Infectious disease
394 Clinical Answers matching * in All Text
Cochrane Clinical Answers
Select all (394)
Export selected citation(s)
Order by Publish Date - New To Old
Results per page 25
1
What is the accuracy of symptom screening for active pulmonary tuberculosis (TB) in children with HIV under five years of age?
Jane Burch, Sera Tort
12 November 2021

Tìm kiếm theo chủ đề

Browse by Topic | Browse by Cochrane Review Group

Browse by Topic

Browse the Cochrane Reviews, Protocols and Clinical Answers.

Set email alerts

a

- Allergy & intolerance

b

- Blood disorders

c

- Cancer
- Child health
- Complementary & alternative medicine
- Consumer & communication strategies

d

- Dentistry & oral health
- Developmental, psychosocial & learning problems
- Diagnosis

e

- Ear, nose & throat
- Effective practice & health systems

g

- Gastroenterology & hepatology
- Genetic disorders
- Gynaecology

h

- Health & safety at work
- Health professional education
- Heart & circulation

i

- Infectious disease
- Insurance medicine

k

- Kidney disease

l

- Lungs & airways

m

- Mental health

n

- Neonatal care
- Neurology

o

- Orthopaedics & trauma

p

- Pain & anaesthesia
- Pregnancy & childbirth
- Public health

r

- Reproductive & sexual health
- Rheumatology

s

- Skin disorders

t

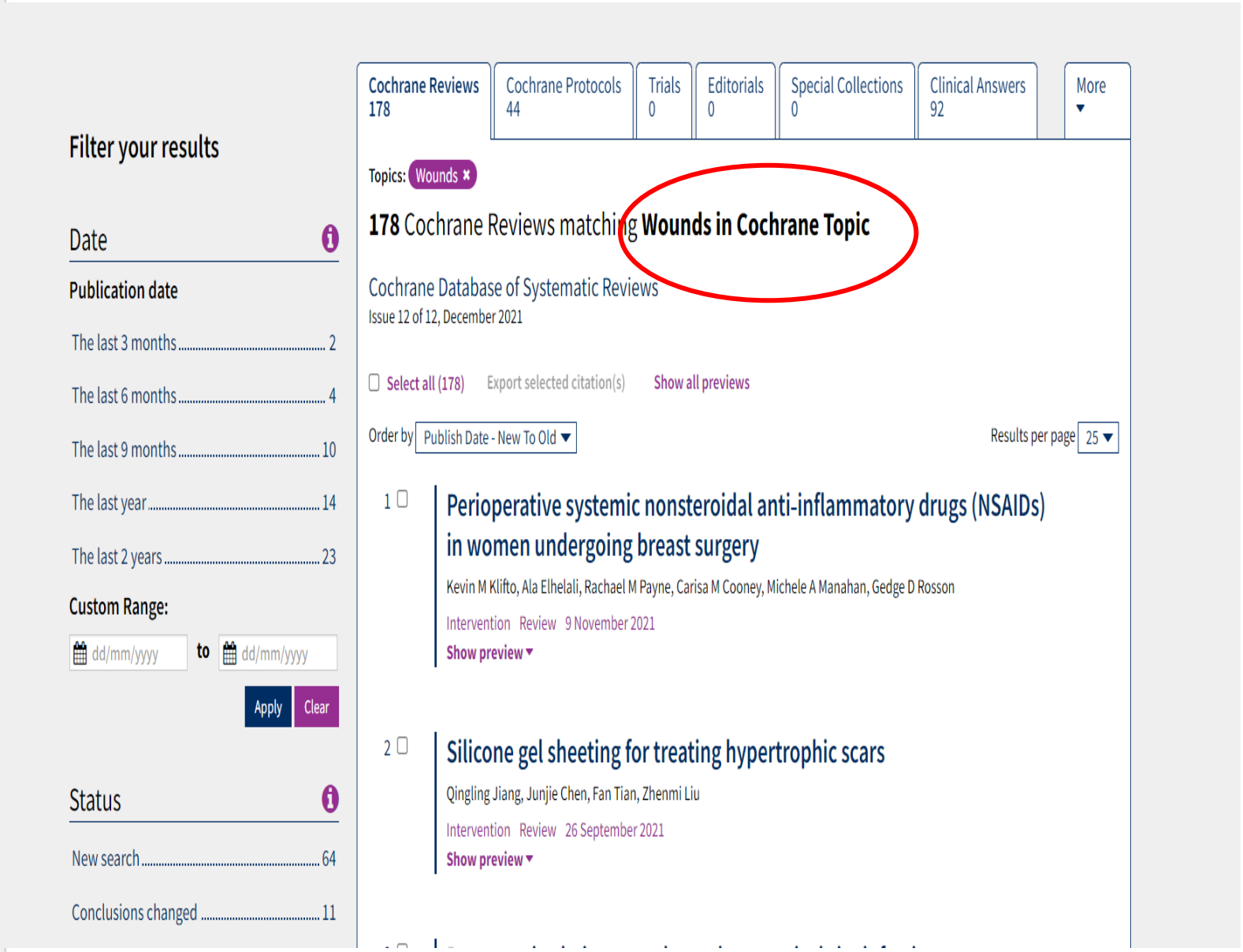
- Tobacco, drugs & alcohol

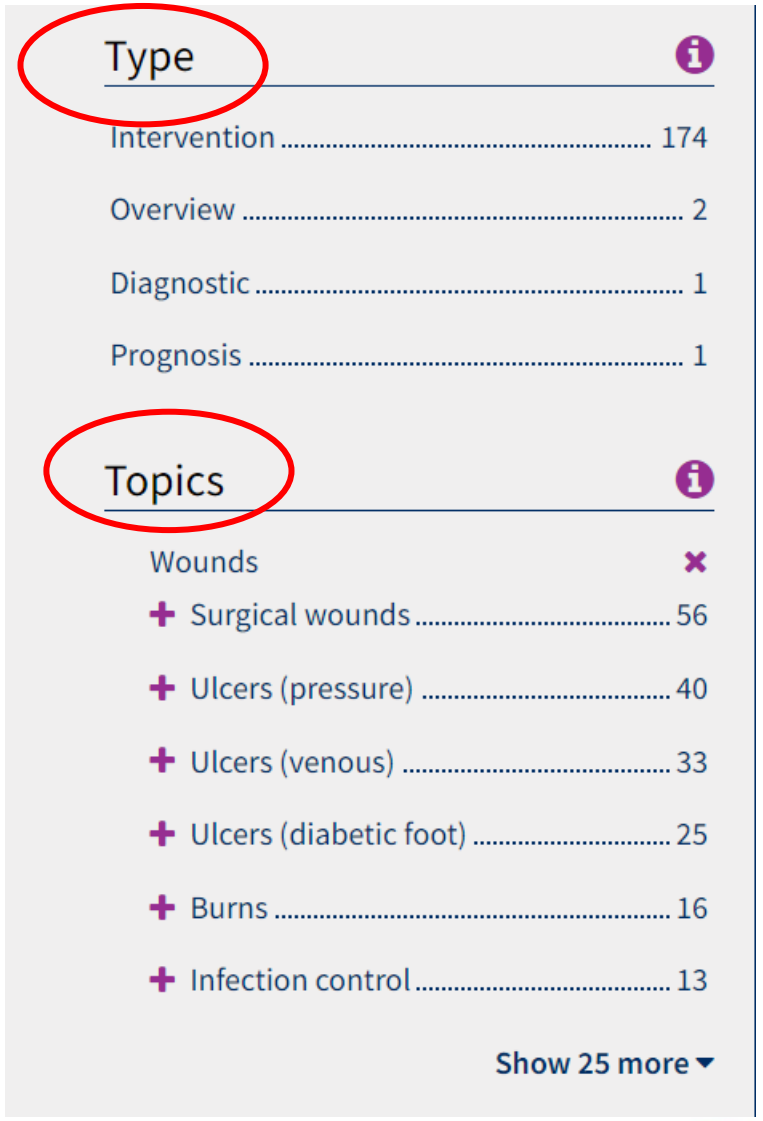
u



Cochrane Interactive Learning

Learn how to conduct Cochrane reviews with Cochrane Interactive Learning





TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Cochrane Database of Systematic Reviews | Review - Intervention

Wound cleansing for treating venous leg ulcers

Niamh EM McLain, Zena EH Moore, Pinar Avsar Authors' declarations of interest

Version published: 10 March 2021 Version history
https://doi.org/10.1002/14651858.CD011675.pub2

View PDF
Cite this Review
Request Permissions
Comment on Review
Read comments on this Review(0)
Print Share Follow
Collapse all Expa

Abstract

Available in English | Español | فارسی | Français | 한국어 | ภาษาไทย | 简体中文

Background

Leg ulcers are open skin wounds that occur below the knee but above the foot. The majority of leg ulcers are venous in orig
occurring as a result of venous insufficiency, where the flow of blood through the veins is impaired; they commonly arise du
blood clots and varicose veins. Compression therapy, using bandages or stockings, is the primary treatment for venous leg
Wound cleansing can be used to remove surface contaminants, bacteria, dead tissue and excess wound fluid from the woun
and surrounding skin, however, there is uncertainty regarding the effectiveness of cleansing and the best method or solutio
use.

Objectives

To assess the effects of wound cleansing, wound cleansing solutions and wound cleansing techniques for treating venous l
ulcers.

Abstract
Plain language summary
Authors' conclusions
Summary of findings
Background
Objectives
Methods
Results
Discussion
Appendices
Information
Authors

Phương pháp tìm kiếm bằng chứng

- PubMed do cơ quan National Center for Biotechnology Information (NCBI) tại thư viện quốc gia Hoa Kỳ xây dựng và phát triển
- Công cụ tìm kiếm: đưa ra từ khóa tìm kiếm -> so từ khóa này với vấn đề cần giải quyết -> trả kết quả tương ứng
- Website: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Phương pháp tìm kiếm bằng chứng

*** Thông tin được lưu trữ trên PubMed bao gồm:**

- Tựa đề
- Tác giả
- Nơi công tác
- Tên tạp chí, tập san, chương sách, … và ngày xuất bản
- Tóm tắt
- Mã số trên PubMed, chỉ số DOI, …

*** Công cụ MeSH (Medical Subject Heading)**

PubMed.gov

Search

Advanced

PubMed® comprises more than 33 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full text content from PubMed Central and publisher web sites.

Chọn liên kết MeSH



Learn

About PubMed
FAQs & User Guide
Finding Full Text



Find

Advanced Search
Clinical Queries
Single Citation Matcher



Download

E-utilities API
FTP
Batch Citation Matcher



Explore

MeSH Database
Journals

Full Send to:

Pressure Ulcer

An ulceration caused by prolonged pressure on the SKIN and TISSUES when one stays in one position for a long period of time, such as lying in bed. The bony areas of the body are the most frequently affected sites which become ischemic (ISCHEMIA) under sustained and constant pressure.

Year introduced: 2006 (1963)

PubMed search builder options

Subheadings:

- analysis
- anatomy and histology
- blood
- cerebrospinal fluid
- chemically induced
- classification
- complications
- congenital
- diagnosis
- diagnostic imaging
- diet therapy
- drug therapy
- economics
- enzymology
- epidemiology
- ethnology
- etiology
- genetics
- history
- immunology
- metabolism
- microbiology
- mortality
- nursing
- organization and administration
- pathology
- physiology
- physiopathology
- prevention and control
- psychology
- radiotherapy
- rehabilitation
- statistics and numerical data
- surgery
- therapy
- urine
- veterinary

PubMed Search Builder

Add to search builder AND

Search PubMed

YouTube Tutorial

Related information

PubMed

PubMed - Major Topic

Clinical Queries

NLM MeSH Browser

MedGen

Recent Activity

PubMed.gov

Search

Advanced

PubMed® comprises more than 33 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full text content from PubMed Central and publisher web sites.

Chọn truy vấn lâm sàng



Learn

About PubMed
FAQs & User Guide
Finding Full Text



Find

Advanced Search
Clinical Queries
Single Citation Matcher



Download

E-utilities API
FTP
Batch Citation Matcher



Explore

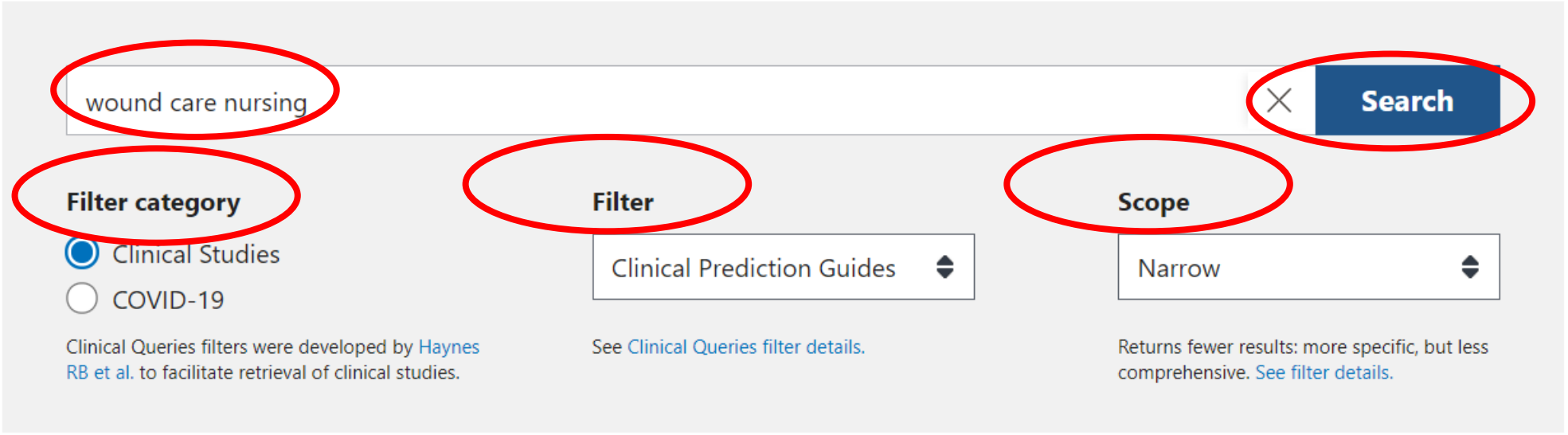
MeSH Database
Journals

CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

PubMed Clinical Queries

This tool uses predefined filters to help you quickly refine PubMed searches on clinical or disease-specific topics. To use this tool, enter your search terms in the search bar and select filters before searching.

Note: The Systematic Reviews filter has moved; it is now an option under the "Article Type" filter on the main PubMed search results page.



Results for Clinical Studies: Clinical Prediction Guides/Narrow

5 of 293 results sorted by: Most Recent

See all results in PubMed (293)

Development and Testing of an Algorithm to Prevent Medical Device-Related Pressure Injuries.

Seong YM, et al. Inquiry. 2021. PMID: 34672226 **Free PMC article.** Review.

PubMed Clinical Queries

This tool uses predefined filters to help you quickly refine PubMed searches on clinical or disease-specific topics. To use this tool, enter your search terms in the search bar and select filters before searching.

Note: The Systematic Reviews filter has moved; it is now an option under the "Article Type" filter on the main PubMed search results page.

diabetes AND foot care

Search

Filter category

- (•) Clinical Studies
- ( ) COVID-19

Clinical Queries filters were developed by Haynes RB et al. to facilitate retrieval of clinical studies.

Filter

Clinical Prediction Guides

See Clinical Queries filter details.

Scope

Narrow

Returns fewer results: more specific, but less comprehensive. See filter details.

Results for Clinical Studies: Clinical Prediction Guides/Narrow

5 of 115 results sorted by: Most Recent

See all results in PubMed (115)

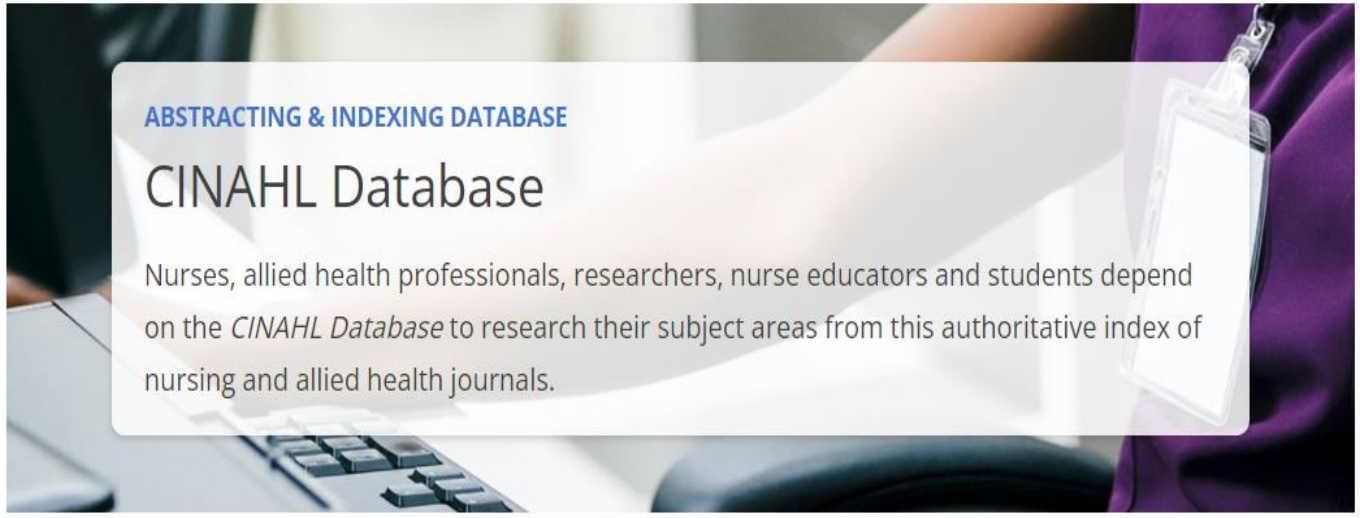
Reliability of Low-Cost Thermometers for Monitoring Foot Temperature.
Wendland D, et al. J Health Care Poor Underserved. 2021. PMID: 34803069

Phương pháp tìm kiếm bằng chứng

- Dữ liệu CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) được hình thành từ năm 1961
- Cung cấp dữ liệu về lĩnh vực điều dưỡng, sức khỏe cộng đồng, y sinh học, chăm sóc sức khỏe
- Websites: https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-database

EBSCO

Contact us



ABSTRACTING & INDEXING DATABASE

CINAHL Database

Nurses, allied health professionals, researchers, nurse educators and students depend on the *CINAHL Database* to research their subject areas from this authoritative index of nursing and allied health journals.

The Most Authoritative Nursing and Allied Health Literature

CINAHL indexes the top nursing and allied health literature available including nursing journals and publications from the National League for Nursing and the American Nurses Association.

For full-text nursing and allied health journals, ***CINAHL Complete*** is the largest full-text companion to the *CINAHL* index.

Content Includes:

3,604 active indexed and abstracted journals

active, peer-reviewed indexed and abstracted journals **3,112**

Title List:

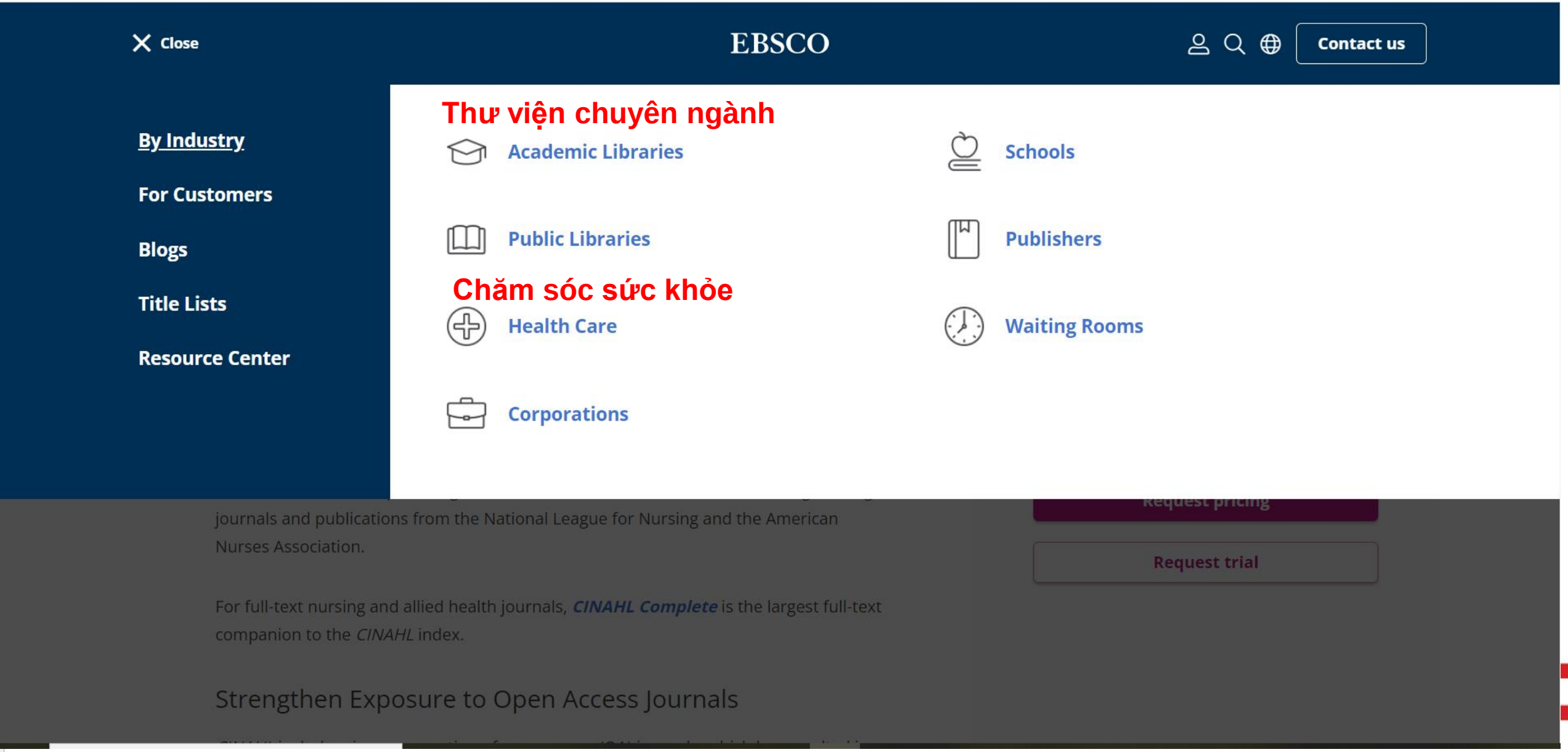
Coverage: **Excel** | **HTML**

CINAHL on EBSCOhost - Versions Compared Flyer

Request pricing

Request trial

CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY


Close
EBSCO
Contact us
By Industry
For Customers
Blogs
Title Lists
Resource Center
Thư viện chuyên ngành
Academic Libraries
Schools
Public Libraries
Publishers
Chăm sóc sức khỏe
Health Care
Waiting Rooms
Corporations
journals and publications from the National League for Nursing and the American Nurses Association.
Request pricing
Request trial
For full-text nursing and allied health journals, CINAHL Complete is the largest full-text companion to the CINAHL index.
Strengthen Exposure to Open Access Journals

Thầy thuốc

Quyết định lâm sàng

Giải pháp nghiên cứu

Điều dưỡng và lĩnh vực liên quan

EBSCO

Contact us

Health Care

Clinical Decision Support | Research Solutions | For Physicians | For Nursing & Allied Health | About



Clinical Decisions

Improve patient outcomes, increase patient engagement and satisfaction and support value-based care with EBSCO's clinical decision support solutions.



DynaMed



Dynamic Health

THANKS!



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

(84-0292) 3 739 730

ctump@ctump.edu.vn

ctump.edu.vn

179 Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ